Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Alvorada

Rua Contabilista Vitor Brum, s/n, Parada 48 - Bairro: Maringá - CEP: 94814-595 - Fone: (51) 3098-3389 - www.tjrs.jus.br - Balcão virtual: (51) 99990-1715 - Email: fralvorada2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5027529-35.2023.8.21.0003/RS

AUTOR: ORESTE TIRLONI
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

ORESTE TIRLONI ajuizou a presente *ação de rito ordinário*, em face de **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS**, todos já qualificados na inicial. Aduziu, em síntese, que é portador da doença *Leucemia Linfóide (CID 10 C 91.1), necessitando do medicamento Ibrutinibe para uso diário, 03 comprimidos de 140mg, para evitar risco rápido de progressão e morte*. Informou que houve negativa da parte ré e que o custo do tratamento, com base no orçamento mais barato, é de R$ 51.890,00 (cinquenta e um mil oitocentos e noventa reais) (01 caixa), não possuindo condições. Liminarmente, requereu seja fornecido o medicamento. No mérito, a confirmação da liminar. Pugnou pela concessão da justiça gratuita. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Concedido o benefício da justiça gratuita e encaminhado os autos ao E-NATJUS (evento 8, DESPADEC1).

Sobreveio nota técnica (evento 15, NOTATEC1).

Indeferida a liminar e determinada a citação (evento 17, DESPADEC1).

Houve a juntada de novos documentos, requerendo seja analisada novamente a tutela de urgência (evento 26, PET1).

Nova remessa ao E-NATJUS (evento 29, DESPADEC1).

Novo parecer técnico (evento 34, INF2).

Houve deferimento da liminar, com as providências de praxe (evento 36, DESPADEC1).

Citado, o corréu Município de Alvorada apresentou contestação (evento 44, CONT1). Preliminarmente, suscitou *(i)* Tema 793 do STF - necessidade de inclusão da União e *(ii)* ilegitimidade passiva. No mérito, em síntese, teceu considerações acerca do planejamento e da necessidade de inserção do usuário no SUS. Declarou que o não tem atribuição para fornecer o medicamento pleiteado, pois está submetido ao sistema de municipalização. Esclareceu que há necessidade de previsão orçamentária. Requereu a improcedência do pedido. Juntou documento.

Citado, o corréu Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação (evento 47, CONT1). Inicialmente, informou que o fármaco foi cadastrado no sistema AME, com previsão de estoque. Afirmou que, em caso de eventual condenação, o fármaco deve ser pleiteado pela Denominação Comum Brasileira. Preliminarmente, requereu *(i)* aplicação do Tema 793 do STF. Teceu considerações quanto a política nacional de prevenção e tratamento antineoplástico, no âmbito do SUS. Requereu aplicação critérios fixados pelo STJ no tema repetitivo nº 106, além da necessidade de apresentação de receituário médico a cada seis meses pelo autor. Requereu a improcedência do pedido.

O autor requereu o bloqueio de valor, haja vista o descumprimento (evento 50, PET1).

O *Parquet* manifestou-se favorável ao bloqueio (evento 53, PROMOÇÃO1).

Houve réplica (evento 54, RÉPLICA1).

Determinada a intimação da parte autora acerca da dispensação do fármaco (evento 56, DESPADEC1).

Após nova intimação, o autor informou que, em consulta ao AME, o medicamento está sendo dispensado administrativamente, sendo a última ocorrendo em 31/10/2024 (evento 71, PET1).

Indicado que a matéria é de julgamento antecipado, encaminhando ao MP para parecer final (evento 73, DESPADEC1).

Parecer final pelo *Parquet* (evento 84, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Os autos vieram para sentença.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Fundamento e decido, com base no artigo 93, IX, da Constituição Federal[1] e nos artigos 11[2] e 489, § 1º[3], ambos do Código de Processo Civil (CPC).

O julgamento antecipado do feito está autorizado, na forma do art. 355, I, do CPC.[4]

II.1 - PRELIMINARES E PREJUDICIAL

Da aplicabilidade do Tema nº 793 do STF

A parte ré, Estado do Rio Grande do Sul e Município de Alvorada, requereram a observância do Tema n.º 793 do STF, com a inclusão da União no polo passivo da demanda.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado como um todo considerado, ou seja, dever de todos os seus entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), de forma solidária, a prestar o direito à saúde, inclusive, é o que se depreende do disposto no art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 793 (RE n.º 855178), fixou a seguinte tese:

> *Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da **saúde**, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.*

Sobre o assunto, transcrevo fundamentação proferida pela Desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, quando do julgamento do recurso de Apelação n.º 70084154244:

> *"[...] Ademais, não há que se falar em formação de litisconsórcio necessário com a União, tendo em vista que está apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão".*

Desse modo, considerando que a parte autora optou por litigar contra o estado do Rio Grande do Sul e o Município de Alvorada/RS, ambos têm, solidariamente, o dever de garantir o direito à saúde pleiteado.

Outrossim, eventual litisconsórcio seria facultativo, por opção do demandante, que escolhe contra quem demandar, tratando-se de obrigação solidária, cumprindo ressaltar que eventual procedência da ação não afetará a União, inaplicável o artigo 114 do Código de Processo Civil no presente caso, podendo a lide ser ou não decidida de modo uniforme para todas as partes.

No mesmo sentido, cito trecho da decisão do STF no julgamento do ARE n.º 1253568/SC, em 26/03/2020:

> *Ademais, como bem ressaltou o juízo de admissibilidade do presente recurso extraordinário, ao examinar o julgamento do recurso-paradigma RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, o Plenário do Tribunal reconheceu existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, **podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente**. - Grifei -*

Colaciono ainda julgados do Tribunal de Justiça Gaúcho:

> *EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO/TRATAMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 793 DO STF. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto que justifique a interposição dos embargos declaratórios. 2. Mesmo que seja prequestionamento da matéria, devem estar presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Não é o caso dos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema repetitivo nº 793 (RE nº 855178), não criou a obrigação de se chamar a União à lide. Apenas reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Seria contraditório a Corte Suprema reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e ao mesmo tempo determinar o direcionamento da ação para a União. Vale ressaltar que cabe à União (Ministério da Saúde) formular as políticas nacionais de saúde, mas não efetuar a sua realização, ou seja, não cabe a esta o cumprimento de tais políticas, como é o caso do fornecimento de medicamentos/tratamentos de saúde. Assim, por ora permanece inalterado o entendimento de que além de não ser adequada a inclusão da União no polo passivo, eis que não existe litisconsórcio necessário, tal ato resulta em maior morosidade na solução da lide, o que não se pode admitir no caso, considerando-se a gravidade da doença que está acometida a parte autora (câncer). 4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito, assim como o Julgador não está adstrito a rebater todas as teses levantadas pelas partes, mas sim a demonstrar logicamente o caminho pelo qual chegou à conclusão (Tema 339 do STF – repercussão geral). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Cível, Nº 70084294750, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 01-07-2020).*

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ADULTO INCAPAZ - SÍNDROME DE DOWN. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178/SE - TEMA 793 - DO E. STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. HIPERTENSÃO PULMONAR TRAMBÓLICA CRÔNICA E EMBOLIA PULMONAR COM MENÇÃO DE COR PULMONALE AGUDO - CID 10.126.0 E 10.127.2. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RIOCIGUAT. PROBABILIDADE DO DIREITO DO RECORRIDO EVIDENCIADA. RISCO DE MORTE DECORRENTE DA EVOLUÇÃO DA MOLÉSTIA. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC DE 2015. Preliminar. Evidenciada a legitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul, e o descabimento do litisconsórcio passivo necessário com a União, em razão da solidariedade dos Entes Públicos na prestação da saúde - art. 196 da Constituição da República -, consoante estabelecido no julgamento do RE n° 855.178/SE – Tema 793 -, do e. STF, independentemente das atribuições de cada ente público, objeto de compensações na via administrativa, consoante o art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90. Precedentes deste tribunal. Mérito. I -[...]. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido(Agravo de Instrumento, Nº 70082894494, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 07-05-2020).*

Desse modo, **não há que se falar na inclusão da União no polo passivo da demanda**, tendo o STF reiterado que a responsabilidade dos entes públicos em matéria de saúde é solidária.

Nesse sentido, **rejeito, também, a preliminar de ilegitimidade do Município**, suscitada pelo ente em contestação (evento 44, CONT1).

II.2 - MÉRITO

Estando o feito em ordem, ausentes nulidades e irregularidades processuais, tampouco outras preliminares ou prejudiciais de mérito para enfrentar, analiso o caso concreto.

Da Assistência à Saúde

Insta mencionar que em conformidade com o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, bem como de acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais pátrios, a responsabilidade dos entes federados, no tocante à saúde, é solidária e integral, podendo o cidadão dirigir a demanda contra qualquer um deles.

Cabe a União, Estados e Municípios, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à vida e saúde, fornecendo atendimento médico e tratamentos à população, bem como disponibilizando os medicamentos necessários aos que não podem adquiri-los por ausência de condições financeiras, conforme preleciona o artigo 196 da Constituição Federal:

> *Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> *Para a efetivação deste direito, determinou o art. 198 da CF/88 a formação de uma rede regionalizada e hierarquizada em um sistema único e descentralizado - Sistema Único de Saúde (SUS) -, cujas diretrizes são as seguintes:*
>
> *I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;*
>
> *II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;*
>
> *III - participação da comunidade.*

Outrossim, a Administração Pública deve se pautar pela obediência ao *Princípio da Legalidade* (à lei e ao direito), porém, sem se furtar ao cumprimento das decisões judiciais.

A independência entre os poderes, não poderá permitir violação de preceitos constitucionais e legais no exercício de suas funções (ou em sua omissão) contando, ainda, com a proteção da não intervenção do Estado-Juiz.

De tal modo, ocorrendo omissão do Poder Público no cumprimento de norma constitucional elevada à categoria de direito fundamental, compete ao Poder Judiciário ordenar que os órgãos públicos competentes adotem as medidas cabíveis a efetivação do direito.

Além disso, o direito a saúde e à vida, como princípios fundamentais, prevalecem sobre qualquer outro.

Por fim, destaco que por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 106, o STJ fixou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

> *(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
>
> *(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
>
> *(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

Da Prova da Moléstia e da Necessidade do Tratamento Postulado

A prestação jurisdicional não pode deixar de considerar a situação individualizada de cada caso.

No caso em comento, a tutela provisória foi deferida no evento 36, DESPADEC1, determinando que os entes públicos fornecessem o medicamento postulado.

Cumpre ressaltar, ainda, que o atendimento da pretensão veiculada na inicial independe de previsão orçamentária, haja vista que a Carta Magna disciplina que os direitos fundamentais devem ser tratados com prioridade não só pela família e pela sociedade, mas, também, pelo Poder Público, afastando a alegação de carência de recursos financeiros como justificativa para a omissão.

Não fosse isso, de regra, não há que se atender a estudos e sugestões de substituição dos remédios emitidos pela respectiva secretaria de saúde, em detrimento da prescrição realizada pelo médico do paciente. O escopo preponderante da administração pública, na espécie, é o barateamento do tratamento e o almejo maior do profissional que atende o enfermo é o melhor para sua saúde.

Jurisprudência amparando tal entendimento:

> *ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico*

bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

No caso dos autos, a patologia que acometeu a parte autora restou comprovada pela prova documental acostada aos autos (evento 1, LAUDO8), *portador Leucemia Linfóide (CID 10 C 91.1):*

LAUDO MÉDICO PARA AÇÃO JUDICIAL

MEDICAMENTO(S)/INSUMO(S) FORA DA LISTA DO SUS OU NÃO FORNECIDO PARA O CID DO PACIENTE

ATENDIMENTO: (x) SUS; ( ) Particular; ( ) Convênio; Qual?

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE: Oreste Tirloni

Cartão SUS

Portador da(s) enfermidade(s) – informar CID(s): leucemia linfoítica crônica CID C91.1

Necessita do(s) medicamento(s)/insumos (fraldas/tiras reagentes para diabéticos/alimentação especial). Nome por extenso. Em caso de **medicamento** deve constar o nome na Denominação Comum Brasileira, bem como, da substância ativa e nome comercializado.

Ibrutinibe

Pelo Período:

medicação de uso contínuo

Posologia, dosagem diária e mensal: 3cp de 140mg (total 420 mg) por dia, uso contínuo

A pretensão encontra respaldo nos artigos 5º, parágrafo 1º, 6º e 196, da Constituição Federal, combinados com o artigo 241, da Constituição Estadual e o artigo 1º da Lei Estadual n.º 9.908/93.

A proteção à inviolabilidade do direito à vida e saúde, deve prevalecer em detrimento a qualquer outro interesse estatal, já que sem ele os demais interesses socialmente reconhecidos não possuem o menor significado ou proveito.

Nesta seara, segue a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DO RESP N.º 1.657.156/RJ (TEMA 106 STJ). DESCABIMENTO NA VIA ORDINÁRIA. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE FORNECER MEDICAMENTOS. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Descabe a suspensão do processo durante sua tramitação ordinária em razão da afetação do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, em se tratando de direito à saúde, a matéria exige urgência e brevidade no julgamento. A decisão de sobrestamento proferida pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo nº 1.657.156/RJ alcança somente os Recursos Especiais interpostos sobre o mesmo objeto. 2. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado Iato sensu, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal. 3. A distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal. 4. A previsão orçamentária não pode limitar a atuação do Estado na efetivação dos direitos sociais e fundamentais. O direito à saúde está diretamente relacionado com a ideia de mínimo existencial, que constitui o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, de forma que a mera alegação da reserva do possível não constitui óbice a tutela jurisdicional de um direito fundamental. 5. Ao Poder Judiciário não cabe decretar a inadequação do fármaco recomendado pelo médico responsável pelo tratamento da autora, ainda que não conste em lista do Sistema Único de Saúde. O profissional da Medicina que mantém contato direto com o paciente é quem tem conhecimento e condições de avaliar e prescrever o tratamento adequado. 6. Por idênticas razões, não prospera a alegação de necessidade de esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS ou de substituição do fármaco por outros medicamentos que estejam inseridos na lista dos fornecidos pelo Poder Público. 7. O contexto probatório revela a hipossuficiência dos demandantes para arcar com os medicamentos, devendo ser fornecidos pelos Entes Públicos. Evidente que possível alteração na situação financeira dos demandantes pode ensejar a suspensão da disponibilização dos medicamentos, o que poderá ser objeto de pedido e prova perante o juízo do cumprimento da sentença. A prova atual alicerça a condenação dos entes públicos na prestação dos fármacos. 8. É devida a comprovação da necessidade dos medicamentos em periodicidade adequada que não onere os demandantes. 9. Remessa Necessária. Considerando que a decisão singular é ilíquida, aplica-se ao caso o disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil e na Súmula nº 490 do STJ. 10. O Estado fica isento do pagamento de custas processuais quanto as serventias estatizadas, nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.121/85. 11. É devido pelo ente municipal o pagamento das custas processuais por metade em face da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.471/2010, o que impõe a aplicação da redação originária do art. 11 da Lei Estadual nº 8.121/1985. APELAÇÃO DOS DEMANDADOS DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS

DEMANDANTES PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078298650, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 08/08/2018).

Assim, diante das alegações médicas, entendo que a não concessão da medicação postulada atentaria diretamente contra o direito constitucionalmente garantido à saúde, enquanto, devido a impedimentos de ordem administrativa, a parte autora teria prejudicada de forma considerável a possibilidade de diminuição dos efeitos decorrentes de sua enfermidade.

Ademais, não há motivos para desacreditar no diagnóstico e prescrição do fármaco, segundo atestado pelo médico assistente da parte autora, quem, justamente por esta circunstância fundamental, detém as melhores condições de avaliá-la e indicar tratamento.

O *Parquet* manifestou-se pela procedência do pedido (evento 84, PROMOÇÃO1).

Diante disso, resta evidente a necessidade da parte autora em receber o tratamento pleiteado, haja vista que é indispensável à manutenção de sua saúde, havendo, inclusive, **risco de morte.**

Do Registro do Fármaco na ANVISA

No tocante ao registro do medicamento perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, verifica-se sua existência sob os registros nº 112363439 e nº 112363445, conforme consulta ao *site*[1] *dessa:*

Resultado da Consulta de Produtos

	Nome do Produto	Complemento da Marca	Tipo de Regularização	Princípio Ativo ou Descrição do Medicamento Notificado	Número da Regularização	Número do Processo	Empresa Detentora da Regularização	Situação da Regularização	Vencimento da Regularização
☐	IMBRUVICA		REGISTRADO	ibrutinibe	112363439	25351.114441/2020-91	JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA - 51.780.468/0001-87	Ativo	10/2032
☐	IMBRUVICA		REGISTRADO	ibrutinibe	112363445	25351.201886/2023-52	JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA - 51.780.468/0001-87	Ativo	09/2034
☐	Imbruvica		REGISTRADO	ibrutinibe	112363412	25351.435416/2014-08	JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA - 51.780.468/0001-87	Inativo	07/2025

Exportar para Excel Voltar

Da (in)capacidade financeira

Restou positivada a incapacidade financeira da parte autora para pagamento do tratamento, haja vista que possui o benefício da gratuidade judiciária e pela fruição dos serviços prestados pela Defensoria Pública.

O pedido veio acompanhado de laudo médico no evento 1, LAUDO8, que demonstra a necessidade do insumo postulado.

Além disso, a ausência de fornecimento de insumos necessários para manutenção dos cuidados do paciente poderá lhe causar danos imediatos.

O orçamento foi juntado (evento 1, DOC11).

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Alvorada, tendo em vista a relevância pública do direito à saúde.

Da Denominação Comum Brasileira

Imperioso destacar que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconhece a possibilidade de substituição do fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira, que possuem o mesmo princípio ativo. Neste sentido: Apelação Cível, N.º 70084379239, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-07-2020.

No caso em análise, o medicamento não foi postulado pelo nome comercial, mas sim pelo princípio ativo: *necessitando do medicamento Ibrutinibe para uso diário, 03 comprimidos de 140mg, para evitar risco rápido de progressão e morte*.

Desde já, assinalo que o fármaco deve ser disponibilizado conforme a denominação comum brasileira.

Das Verbas Honorárias

No que se refere a possibilidade de condenação do Estado em honorários, quando a parte vencedora for representada pela Defensoria Pública, necessário atentar-se ao Tema 1002 do STF.

Em 26/06/2023, a Corte Suprema julgou o RE nº 1140005 pelo rito dos recursos repetitivos (**Tema nº 1002**), e definiu o seguinte:

*Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da **Defensoria** Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: "**1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele***

que integra; *2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.*

Além disso, em razão da decisão, houve revogação da súmula 421 do STJ[2].

Logo, além do Município, o Estado também é responsável pelo pagamento de honorários à Defensoria Pública, sendo plenamente cabível a fixação.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **ORESTE TIRLONI**, contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS**, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para **TORNAR DEFINITIVA** a tutela provisória de urgência concedida (evento 36, DESPADEC1), determinando que os requeridos forneçam gratuitamente à parte autora o medicamento *Ibrutinibe,* enquanto necessário e conforme prescrição médica, admitida a dispensação pela denominação comum brasileira. A necessidade do medicamento poderá ser reavaliada a cada seis meses, mediante a apresentação de atestados médicos que justifiquem o prosseguimento do tratamento.

Condeno cada réu ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Os requeridos são isentos do pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 5º, I, da Lei Estadual n.º 14.634/2014.

Apresentado embargos de declaração com pedido modificativo, vista à parte adversa e, por fim, venham conclusos.

Imperiosa a Remessa Necessária do feito, por se tratar de sentença ilíquida, hipótese descrita no enunciado da Súmula n.º 490 do STJ, estando sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **FABIANA ARENHART LATTUADA, Juíza de Direito**, em 07/05/2025, às 16:31:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10081027762v8** e o código CRC **2db8dac9**.

---

1. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:[...]IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...] ↩

2. Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. ↩

3. Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.[...] ↩

4. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver necessidade de produção de outras provas; [...] ↩

1. https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=23516 ↩

2. https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/22042024-Corte-Especial-cancela-sumula-sobre-honorarios-advocaticios-da-Defensoria-Publica.aspx ↩